

RICARDO ANDRE DA SILVA

HD:

MEDICO:

MEDICAMENTOS:

IMC

CIRCUNF. DE PESCOÇO

PA:

OXIMETRIA:

11/10 P = 4-12 cmH₂O

21 IAH = 6.2 no exame cl 12 pressão

15/10 P = 6.5 cmH₂O

21 IAH = 1.1

21 m. de uso: 6h14 — fua

02/12 P = 7.5

21 IAH = 0.7

21 m. de uso: 7h20' — fua

Nº série do CPAP (sleep)

10/01 P = 7 cmH₂O

24 Fuga = 2.5 l/min.

13/05 P = 7 cmH₂O

24 IAH = 0.2

24 m. de uso: 6h30'

Relata ↑ dos despertares

fua

Troca aparelho pl Autoset 510

Volto pl Fischer.

14/03 P = 11 cmH₂O

25 IAH = 0.2

início 7 cmH₂O

estava despertando

muito — fua

10/06/25 P=7 cm H₂O
IAH: 0,2 c/h
med. em 0: 7 h 18'
fuga: 38 l/m

Relata que a apaulha
está fazendo lobulho
Lerou dream station
p/ teste

Natacha

11/07/25 Reti treco da apaulha da fisher p/ da
philips
Pauta: 7 - 10 cm H₂O

Natacha



Otorrinolaringologia • Fonoaudiologia • Medicina do Sono
Cirurgia Plástica • Mastologia

Salute CPAP com

p d. 12-1-20

Salute apr 30

dr d. 30

7

Dr. Luciano Rotella
Otorrinolaringologista
CRM 111556

5 7410
2021

Tel.: (12) 3911-2253 / 3207-2289

Rua Teopompo de Vasconcelos, 128 - Vila Adyana - CEP: 12243-830 - São José dos Campos/SP



Instituto do Sono
Rua Marselhesa, 500 – Vl. Clementino
São Paulo – SP – CEP 04020-060
Tel.: (11) 2108-7777

Nome: RICARDO ANDRE DA SILVA
Sexo: M
Peso: 95.0 Kg
Exame: 32273922
ID: 3292078
Médico solicitante: Dr(a). LUCIANO AUGUSTO ROTELLA BRAGA

Idade: 35 anos
Altura: 186.0 cm

IMC: 27.5 Kg/m²

Atendimento: 17960791
Data: 23/04/2021

Laudo de Polissonografia: Resultado

O exame foi iniciado às 23:03:13 horas e finalizado às 05:19:25 horas. A **latência para o início do sono** foi de 47.1 min e a **latência para o início sono REM** de 138.0 min. O **tempo total de sono (TTS)** foi de 225.0 minutos, com **eficiência do sono** de 59.8%. A distribuição dos estágios do sono mostrou 2.2% de **estágio N1**, 44.0% de **estágio N2**, 41.1% de **estágio N3** e 12.7% de **sono REM**. O **tempo acordado após o adormecer** foi de 61.5 min. Ocorreram 36 **despertares**, sendo o índice de 7.5 (nº/h). O **índice de movimentos periódicos de membros inferiores** foi de 0.0 (nº/h), sendo 0.0 (nº/h) **associados a despertares**.

O número total de eventos respiratórios foi de 24, sendo 0 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 24 hipopneias obstrutivas, 0 hipopneias centrais e 0 "RERAs". O **índice de distúrbio respiratório (IDR)** foi de 6.4 (nº/h) e o **índice de apneia/hipopneia (IAH)** 6.4 (nº/h). O **índice de apneia/hipopneia obstrutiva (IAHO)** foi de 6.40 (nº/h) e o **índice de apneia/hipopneia central (IAHC)** foi de 0.00 (nº/h).

A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) **basal** foi de 91%, a **média** 94% e a **mínima** de 86%. O **índice de dessaturação** foi de 18.9 (nº/h) durante o sono REM e de 2.4 (nº/h) durante o sono NREM. Permaneceu 0.4% do tempo total de registro com SpO₂ abaixo de 90%.

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apneias + Hipopneias + RERAs

Protocolo: 76655321233
Nome: RICARDO ANDRE DA SILVA
DN: 13/03/1986
Solicitante: Dr.(a) LUCIANO AUGUSTO ROTELLA BRAGA

Data: 24/4/2021

Unidade: LAVOISIER BORBA GATO



00031RUJYFV00302M

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEIOS DA FACE

Indicação clínica: Em investigação de sinusopatia.

Técnica: Aquisição volumétrica multislice sem a administração do meio de contraste iodado venoso.

Análise:

Septo nasal sinuoso, com maior inclinação da porção óssea superior para a esquerda.

Laterorrinia para a esquerda.

Fóveas etmoidais assimétricas, mais baixa à direita.

Proeminência do componente mucoso das conchas e fossas nasais pode estar relacionada ao ciclo nasal ou a processo inflamatório (rinite). Recesso olfatório esquerdo parcialmente obliterado por interposição mucosa.

Expansão basilar e pneumatização dos recessos lateral e pterigoideo do seio esfenoidal esquerdo; pequena extensão maxilar do seio esfenoidal esquerdo; pneumatização do processo clinoide anterior esquerdo (variantes anatômicas).

Leve espessamento do revestimento mucoso dos seios maxilares, da parede anterior dos seios esfenoidais e de algumas células etmoidais. Cistos de retenção/pólipos nos seios maxilares.

Sinais de tratamento endodôntico e periapicopatia relacionados ao dente 26, com abaulamento e pequenas discontinuidades ósseas no assoalho do seio maxilar adjacente. O espessamento mucoso lobulado/cistos de retenção nesta região pode estar relacionado a algum grau de processo inflamatório sinusal de origem odontogênica. Não há material com formação de nível líquido.

Demais seios paranasais com aeração habitual. Recesso esenoetmoidal esquerdo obliterado por espessamento mucoso.

Infundíbulos, recessos frontais e esenoetmoidal direito púrvios.

Não há evidência de deiscência significativa das lâminas papiráceas, canais carotídeos e canais ópticos.

Rinofaringe de contornos regulares.

Ápices orbitários, forames ovais e redondos e fossas pterigopalatinas sem alterações evidentes.

Proeminência das tonsilas palatinas e linguais; leve medianização dos pilares amigdalianos posteriores; palato mole alongado e espessado. Os achados estreitam o calibre da coluna aérea faríngea, com menor área transversa de 82 mm² no plano da úvula (normal acima de 100 mm²), e podem ser encontrados em indivíduos roncadores e/ou com a síndrome da apneia obstrutiva do sono.

Erosão da coroa dentária (cárie) e sinais de tratamento endodôntico no elemento dentário 15.

DR. CARLOS ALBERTO FERREIRA COELHO
NETO
CRM-162924